

Préparation colique et anesthésie générale

Horaire, jeûne, patients à risque, hydro-électrolytique, synthèse & sources



Résumé : la coloscopie est la méthode de référence pour l'exploration du côlon ; la qualité de la préparation colique conditionne le taux d'intubation caecale et le taux de détection d'adénomes. La grande majorité des coloscopies en France est réalisée sous anesthésie générale — une collaboration étroite entre anesthésistes et gastroentérologues est nécessaire sur la prescription et les modalités de la préparation.

Horaire d'administration de la préparation colique

Situation	Constats et recommandations pratiques
Coloscopie le matin	La prise fractionnée avec pause nocturne est supérieure à la prise complète la veille, sur la tolérance globale, l'efficacité et l'observance (méta-analyse de 47 essais, tous produits confondus) — également meilleur taux de détection des lésions planes et meilleure volonté des patients de reprendre le même type de préparation. Vrai pour PEG, phosphate de sodium (OPS) et picosulfates.
Coloscopie l'après-midi	La prise complète le matin même peut être envisagée. Pour le PEG 4 L : améliore qualité et tolérance (moins de troubles du sommeil et de ballonnements). Pour le PEG 2 L + acide ascorbique : améliore la tolérance mais pas l'efficacité. Pour les OPS : améliore efficacité et tolérance et préférée des patients vs 2 doses (veille + matin).
Délai préparation → coloscopie	La qualité de la préparation est inversement corrélée au délai écoulé depuis la dernière dose (jusqu'à -10 %/heure dans une étude). Délai optimal identifié : 3 à 5 heures entre la fin de la purge et le début de la coloscopie (au-delà de 5 h, la qualité se dégrade). Un délai court n'augmente pas le risque d'impériosité fécale pendant le transport domicile → unité d'endoscopie.

Délai minimal entre préparation colique et anesthésie

Le jeûne préopératoire standard (patients sans risque de retard de vidange gastrique) est de **2 heures pour les liquides clairs** et **6 heures pour les solides**. Les liquides de préparation colique se comportent comme des liquides clairs. Le volume gastrique résiduel après préparation colique (fractionnée ou non) n'est pas différent de celui observé après une gastroscopie simple sans préparation, y compris pour un jeûne de 2 à 3 h — la préparation fractionnée n'augmente donc pas le résidu gastrique. Une validation échographique retrouve un estomac vide 2 heures après la prise de phosphate de sodium + 750 ml de liquide clair.

Recommandation pratique : un délai de **3 heures** entre la dernière prise de préparation colique et l'induction anesthésique répond aux exigences de sécurité, chez les patients sans retard de vidange gastrique. Les autres liquides clairs restent autorisés jusqu'à 2 heures avant l'anesthésie.

Patients à risque de vidange gastrique retardée

À différencier du risque de résidu gastrique important : le risque d'**inhalation par régurgitation** en dehors d'un estomac plein, majoré en cas de reflux gastro-œsophagien sévère (avec ou sans hernie hiatale), plus fréquent chez le patient obèse et la femme enceinte. Le volume gastrique résiduel critique augmentant le risque de régurgitation passive se situe entre 25 et 200 ml.

Tableau I — Situations ralentissant la vidange gastrique

- Douleur aiguë
- Prise d'opiacés
- Sclérodermie
- Amylose
- Ulcère gastro-duodénal
- Vagotomie
- Dysautonomie neurovégétative (syndrome de Shy-Drager)
- Tétraplégie
- Maladie de Parkinson
- Diabète ancien mal équilibré
- Occlusion intestinale

Le tabagisme chronique ralentit la vidange gastrique, mais **le port de patch nicotinique ne la modifie pas** — l'abstention tabagique dans les heures précédant l'anesthésie limite l'hypersécrétion gastrique. L'obésité et la grossesse en dehors du travail, l'anxiété seule et les benzodiazépines n'altèrent pas la vidange gastrique.

Préparation colique et anesthésie générale

Horaire, jeûne, patients à risque, hydro-électrolytique, synthèse & sources



Troubles hydro-électrolytiques et interactions médicamenteuses

Produit	Précautions
Phosphate de sodium	Risque d'hyperosmolarité, hyponatrémie, hypernatrémie, hyperphosphatémie et hypokaliémie. L'hyponatrémie (absorption excessive de fluide hypotonique) touche surtout l'insuffisant rénal et le sujet âgé, et peut donner des crises convulsives. Le risque d'hyperphosphatémie (pouvant aller jusqu'à une néphropathie aiguë) est majoré en cas d'insuffisance rénale, chez le sujet âgé, en présence d'une cardiopathie/néphropathie/diabète, ou sous IEC/ARA II/diurétiques/AINS. Contre-indiqué chez les sujets < 18 ans et > 65 ans. Éviter avec les diurétiques de l'anse (hypokaliémie) et les digitaliques (toxicité cardiaque/torsade de pointe favorisée par l'hypokaliémie).
PEG (polyéthylène-glycol)	Induit peu de désordres hydroélectrolytiques — meilleure tolérance que le phosphate de sodium en cas d'insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque congestive. De rares cas de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique rapportés. Chez le sujet de plus de 85 ans, des hypokaliémies et plus rarement des hyponatrémies ont été décrites — un ionogramme sanguin peut être utile avant la coloscopie dans cette population. À ingérer à au moins 2 heures de distance de toute autre prise médicamenteuse.

Conclusion et tableau de synthèse pratique

Une préparation colique optimale doit être efficace, acceptée et comprise par le patient, sans effet secondaire majeur. L'horaire de prise et le fractionnement de la dose sont des critères importants de réussite, quelle que soit la méthode utilisée. Un délai de 3 h entre la dernière prise de préparation et l'induction anesthésique semble raisonnable pour garantir l'absence de risque d'inhalation chez les patients sans ralentissement de la vidange gastrique. La communication entre les différents acteurs (anesthésiste/gastroentérologue) sur la stratégie de préparation envisagée est un gage de sécurité pour le patient.

Tableau II — Dernières prises autorisées selon l'horaire programmé de la coloscopie

Horaire de l'examen	Alimentation légère jusqu'à	Préparation colique jusqu'à	Autres liquides clairs jusqu'à
8h - 10h	2h	5h	6h
10h - 12h	4h	7h	8h
12h - 14h	6h	9h	10h
14h - 16h	8h	11h	12h
16h - 18h	10h	13h	14h

Sources et avertissement

Bulois P, Bazin JE, Lapuelle J, Al Nasser B, Chaussade S, Bonnet F, Robaszekiewicz M, Ecoffey C, au nom des conseils d'administration de la SFED (7 juillet 2016) et de la SFAR (validation 21 septembre 2016), « Préparation colique et anesthésie générale : position commune SFED/SFAR ». 30 références bibliographiques dans le texte intégral (non reproduites ici).

Avertissement : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle condense la justification scientifique détaillée (méta-analyses, essais individuels) mais reprend intégralement les conclusions pratiques, seuils et tableaux du texte source. Elle ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SFED/SFAR. Ce document n'imprime aucune grille de grade ni recommandation numérotée — les mentions « il faut »/constats factuels reprennent la formulation du texte source.